



ORIGINAL

Efectividad de la terapia asistida con animales en pacientes con demencias, una revisión sistemática



M.E. Gómez García^a, M. Jiménez Palomares^b, J. Rodríguez Mansilla^b,
B. González Sánchez^{b,*}, M. González López-Arza^b y E.M. Garrido Ardila^b

^a Terapia Ocupacional, Universidad de Extremadura, Cáceres, España

^b Departamento Terapéutica Médico-Quirúrgica, Facultad de Medicina. Universidad de Extremadura, Badajoz, España

Recibido el 17 de enero de 2017; aceptado el 17 de mayo de 2017

Disponible en Internet el 29 de julio de 2017

PALABRAS CLAVE

Terapia asistida
con animales;
Demencia;
Enfermedad
de Alzheimer;
Perros

KEYWORDS

Animal assisted
therapy;
Dementia;
Alzheimer's disease;
Dogs

Resumen

Objetivo: Sintetizar la efectividad presentada por estudios originales previos de la terapia asistida con animales en la sintomatología de personas con demencia.

Material y métodos: Se desarrolló una estrategia de búsqueda en las bases de datos PUBMED, DIALNET, PEDro y CSIC con el fin de captar todos aquellos ensayos clínicos publicados entre 2003 y 2015 en inglés y español. Los términos de búsqueda incluyeron la combinación de las palabras clave: «dog therapy, dementia, pet therapy, mental illness, animal assisted, elderly patients, animal assisted therapy, terapia asistida con animales, demencia, Alzheimer». Se seleccionaron 3 registros de los 157 localizados tras aplicar los criterios de inclusión.

Conclusiones: La terapia más utilizada a la hora de llevar a cabo terapia asistida con animales en demencia es la canina. Esta terapia produce una mejora en el comportamiento, estado de ánimo, calidad de vida, actividades de la vida diaria y en el estrés mental de personas que padecen demencia.

© 2017 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Effectiveness of animal-assisted therapy in patients with dementia: A systematic review

Abstract

Objective: To analyse the effectiveness of animal-assisted therapy on the symptoms of dementia as shown in previous studies.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: blgonzalezs@unex.es (B. González Sánchez).

Material and methods: A search strategy was developed using the PUBMED, DIALNET, PEDro and CSIC databases to capture all clinical trials published between 2003 and 2015 in English and Spanish. Search terms included the combination of the keywords: "dog therapy, dementia, pet therapy, mental illness, animal assisted, elderly patients, animal assisted therapy, dementia, Alzheimer's." Three records were selected from the 157 located after applying the inclusion criteria.

Conclusions: The dog is the most commonly used in animal-assisted therapy in dementia. This therapy produces an improvement in behaviour, mood, quality of life, activities of daily living, and mental stress of people with dementia.

© 2017 Asociación Española de Fisioterapeutas. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

La demencia es una de las principales causas de discapacidad, que provoca gran dependencia y, por lo tanto, conlleva a la institucionalización, generando una gran carga socio-sanitaria. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud incita a los gobiernos a tomar medidas que reduzcan el impacto socio-sanitario de esta patología¹.

En la enfermedad se ven afectados la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado, y en ocasiones es precedido, por el deterioro del control emocional, del comportamiento social o de la motivación².

En la actualidad no existe un tratamiento curativo para los diferentes tipos de demencia³; sin embargo, existen fármacos y terapias no farmacológicas que han demostrado tener una eficacia en el control de los síntomas cognitivos y que puede mejorar la funcionalidad y calidad de vida de estos pacientes^{3,4}.

El tratamiento no farmacológico (TNF) hace referencia a diferentes tipos de actuaciones no químicas, focalizadas y replicables que pretenden mejorar la calidad de vida de las personas con demencia⁵. Cualquier TNF ha de tener en cuenta las características de la persona a la que se dirige y ha de contar con formación suficientemente para que cualquier profesional cualificado pueda ponerlo en práctica⁶.

Hoy en día, según indica la evidencia médica, entre los diferentes tipos de TNF orientadas al enfermo de demencia, se está poniendo en práctica lo que se denomina la terapia asistida con animales. Esta terapia consiste en intervenciones en las que un animal es incorporado como parte integral del tratamiento con el objetivo directo de promover la mejora de las funciones físicas, psicosociales y cognitivas de las personas tratadas^{7,8}.

Su ámbito de aplicación es extenso y se ha visto mejoras evidentes en niños o adolescentes de centros para personas con trastorno del desarrollo, sobre todo en pacientes que presentan síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral o déficit de atención^{9,10}, en hospitales¹¹ centros penitenciarios y de menores¹² en programas para pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana¹³, en víctimas de malos tratos

y abusos sexuales¹³. A nivel general, se ha visto que la interacción con el animal permite disminuir el estrés y el dolor, además de incrementar la movilidad y la fuerza muscular¹¹ y mejorar la autoestima y las relaciones sociales¹³.

No obstante, hoy en día su aplicación se está extendiendo al ámbito de la geriatría^{14,15}, sobre todo para mejorar la calidad de vida, mejorando aspectos a nivel físico, emocional y mental¹⁵.

Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo de este estudio es sintetizar la efectividad presentada por estudios originales previos de la terapia asistida con animales en la sintomatología de personas con demencia.

Material y métodos

Revisión bibliográfica de ensayos controlados, ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados. Los criterios de inclusión son: artículos publicados en inglés o español desde enero del 2003 hasta marzo del 2015, que incluyan a pacientes con demencia y que hayan recibido terapia asistida con cualquier tipo de animal.

Se excluyeron las publicaciones anteriores a la fecha indicada, las revisiones bibliográficas y las publicaciones que no se encuadraran dentro de las indicadas en los criterios de inclusión.

Dos revisores independientes (M.J. y M.E.G.) realizaron la búsqueda, la selección y la crítica de los artículos encontrados. En caso de desacuerdo, se empleó una puesta en común de los resultados y se llegó a un consenso entre ambos.

Se utilizaron las bases de datos electrónicas, PUBMED, Dialnet, CSIC (IME) y Physiotherapy Evidence Data base (PEDro), excluyendo la búsqueda en literatura gris.

Se realizaron 4 estrategias de búsqueda entre el 13 y 27 de marzo del 2014. Las búsquedas se realizaron con la combinación de los siguientes términos: «dog therapy, dementia, pet therapy, mental illness, animal assisted, elderly patients, animal assisted therapy, terapia asistida con animales, demencia, Alzheimer», unidas por el operador booleano «AND» o el operador booleano «Y» en aquellas bases de datos en las que la búsqueda se realizó en español.

Selección de los estudios

Como norma general, se realizó una preselección de las publicaciones considerando su adecuación, potencialmente, a la temática propuesta en esta revisión revisando título y resumen.

Se estableció una selección de artículos completos y se procedió a la lectura de su resumen o abstract, excluyendo aquellos artículos que no cumplieran con los criterios de inclusión anteriormente mencionados.

Las publicaciones que superaron los criterios de inclusión se sometieron a una lectura completa para su posterior análisis e inclusión en esta revisión.

Para el análisis de la calidad metodológica de los estudios incluidos se utilizó la escala PEDro¹⁶, compuesta por 11 criterios con respuestas «sí» (S) o «no» (N) y un rango de puntuación de 0 a 10, según tengan calidad metodológica baja, moderada o excelente.

Los estudios se consideran de alta calidad si la puntuación es mayor a 5 (6-8: bueno, 9-10 excelente); calidad moderada, si es de 4 o 5 (estudio justo) y baja calidad, si es inferior a 4 (estudio pobre).

Los 11 criterios que evalúa la escala PEDro son: especificación de los criterios de elegibilidad; asignación aleatoria; asignación ocultada; base comparable; paciente «enmascarado»; terapeuta «enmascarado»; evaluador «enmascarado»; seguimiento del sujeto; análisis del tipo intención de tratar; comparaciones estadísticas entre los grupos, y medida de variabilidad y punto de medidas.

Resultados

De los 157 trabajos seleccionados durante el proceso, se incluyeron 3 conforme a los criterios de inclusión y exclusión anteriormente expuestos. El proceso de búsqueda y selección de los estudios queda reflejado en la [figura 1](#).

Descripción de los estudios

Las principales características de los estudios incluidos quedan reflejadas en la [tabla 1](#).

Las medidas de los resultados están relacionadas con los cambios producidos a nivel conductual/comportamiento, estado de ánimo, calidad de vida/autonomía personal y estado cognitivo a través del TNF de terapia asistida con animales.

Conductual/comportamiento

Los problemas conductuales o de comportamiento son una serie de síntomas frecuentes en las personas con demencia que se reflejan en cambios en la forma de actuar del paciente; se comportan de manera diferente o bien su personalidad ya no es la misma. Son, por lo tanto, problemas que aumentan a medida que avanza la enfermedad¹⁷. Uno de los artículos¹⁸ incluidos en esta revisión realiza una evaluación de los problemas de comportamiento, comparando los resultados entre los pacientes con demencia que han llevado a cabo la terapia con animales y aquellos que han realizado otro tipo de terapia o no han realizado ninguna.

El trabajo realizado por Majić et al.¹⁹ muestra en sus resultados que ninguno de los grupos presentó mejora en los síntomas conductuales tras la aplicación del tratamiento. La agitación y la agresión evaluada a través de la escala Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) en el grupo que fue sometido a 10 sesiones de terapia con animales durante 10 semanas se mantuvo constante durante el tratamiento con animales ($p < 0,05$) y a las 4 semanas de finalizar el tratamiento no se observaron cambios significativos en el comportamiento en comparación con los datos iniciales ($p = 0,81$). Sin embargo, el grupo control, que no realizó terapia con animales, sino el tratamiento habitual, presentó un empeoramiento tanto en la agitación como en la agresión ($p = 0,001$) comparando las puntuaciones del inicio con las del final del estudio, una vez pasadas 4 semanas.

Estado de ánimo

La depresión es uno de los trastornos del estado de ánimo más frecuentes en las personas que presentan demencia; este estado depresivo modifica significativamente la vida de la persona que lo presenta, afectando al sueño, la alimentación, la capacidad de reacción y acción, la forma de pensar y de relacionarse con el entorno¹⁷. Encontramos en esta revisión 2 artículos que investigan los efectos que la terapia asistida con animales tiene en el estado anímico de las personas con demencia^{18,19}.

En este aspecto, Majić et al.¹⁹ observaron una estabilidad de la depresión tras finalizar la terapia asistida con animales durante 4 semanas aplicada en ancianos con diferentes síndromes demenciales ($p = 0,069$). Mientras que en el grupo control que no recibió dicha terapia hubo un empeoramiento de su estado anímico y, por tanto, de los síntomas depresivos ($p < 0,001$) al finalizar el estudio si comparamos con los resultados al inicio del mismo.

Investigaciones han observado que ese mantenimiento de la depresión se producía tanto en el grupo que realizaba la terapia asistida con animales como en los grupos controles, que realizaban terapias con humanos²⁰ o incluso cuando la presencia del animal estaba en los 2 grupos¹⁹. En este último caso en el grupo control solamente el animal fue visualizado por los participantes, no hubo interacción con él; sin embargo, en el grupo experimental hubo un contacto directo con el perro. Los datos en la escala de depresión geriátrica (GDS) se obtuvieron tanto al inicio como al final del estudio. Al finalizar la intervención, se mostró una mejoría en ambos grupos en lo referido a la depresión ($p = 0,070$), por lo que simplemente la presencia de un animal mejora el estado anímico, no siendo necesario la interacción directa con él¹⁹.

Calidad de vida/autonomía personal

El estudio de Moretti et al.¹⁸ evalúa la eficacia de la terapia asistida con animales en la calidad de vida de la persona con demencia.

Moretti et al.¹⁸ comprobaron que tanto la terapia asistida con animales, como la presencia de los mismos en las sesiones, mejoran la calidad de vida de los pacientes con demencia. Aunque se observa que esta mejoría es ligeramente mayor en el grupo experimental que llevó a cabo terapia con animales.

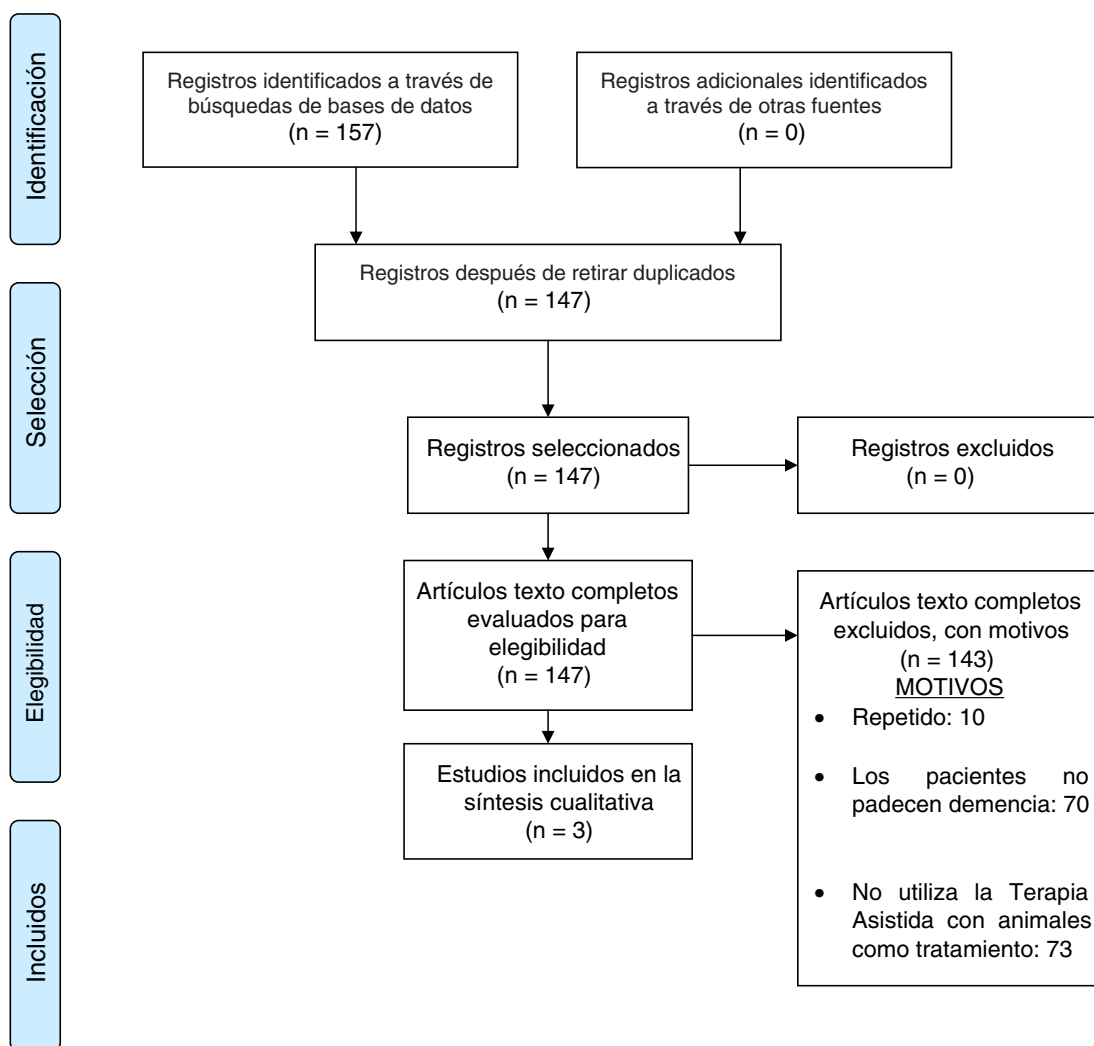


Figura 1 Proceso de búsqueda y selección de los estudios.

Estado cognitivo

Investigaciones han estudiado la influencia de la terapia con animales en las funciones cognitivas de los ancianos con demencia. Se ha encontrado 2 estudios que hacen referencia a esta temática^{19,21}.

A la hora de analizar los resultados encontramos diferencias en ambos estudios. En el primero, realizado por Mosello et al.²¹ no se observaron mejoras en la cognición ni en el Neuropsychiatric Inventory (NPI) a lo largo de la investigación; sin embargo, los resultados obtenidos en la segunda investigación¹⁹ fueron beneficiosos para los que formaron parte del grupo intervención, ya que muestran una mejoría en la función cognitiva comparando los resultados iniciales con los del final del tratamiento ($p=0,06$), y en el grupo control ($p=0,941$), aunque la diferencia no fue significativa¹⁹.

Calidad metodológica

Las variables han sido evaluadas con calificaciones de «sí» o «no», según la presencia o no del criterio estudiado, tal y como se refleja en la [tabla 2](#). Al poner «no» no aseguramos que el estudio no tenga esa característica, sino

que al revisar el artículo completo no se ha encontrado ese requisito reflejado en el texto.

Dos estudios^{18,19} obtuvieron una puntuación de 8, estudio bueno, y uno²¹ de 5, estudio justo.

El criterio 1, especificación de los criterios de elección, se cumple en los 3 estudios incluidos en esta revisión^{18,19,21}, al igual que los criterios 4, base comparable, 8, seguimiento del sujeto, 9, análisis del tipo intención a tratar, 10, comparaciones estadísticas entre los grupos, y 11, medida de variabilidad y punto de medidas.

El trabajo realizado por Moretti et al.¹⁸ es el único que presenta asignación oculta y cegamiento de los terapeutas, criterios 3 y 6 respectivamente.

Los criterios 2 y 5 solo se cumplen en el trabajo realizado por Majić et al.¹⁹.

Discusión

Si bien es cierto que cada vez se está utilizando más la terapia asistida con animales en la asistencia clínica, hasta el momento son pocos los estudios publicados sobre esta temática y, si nos centramos en el objetivo de esta revisión,

Tabla 1 Descripción de los estudios incluidos

Autor/año	Objetivo del estudio	N.º sujetos	Tipo de intervención	Duración y medidas	Instrumentos valoración	Resultados
Mosello et al. ²¹ , 2011	Evaluar el efecto de la terapia asistida con los perros en la cognición, BPSD, el estado emocional y la actividad motora en pacientes con enfermedad de Alzheimer en estadio grave institucionalizados	N = 10 Edad media 79	3 semanas realizando actividades con perros de peluche 2 semanas de terapia asistida con animales. 10 minutos de interacción directa por participante	Duración: 3 sesiones por semana Durante 8 semanas Evaluación: evaluaciones antes de comenzar con el programa de terapia asistida con perros, inmediatamente después de cada intervención y a las 3 h de terminar cada intervención	CA Severe Impairment Battery CSDD BPSD NPI CMAI OERS ABMI	Se asoció a una disminución de la ansiedad y la tristeza y un aumento en las emociones positivas y la actividad motora en el grupo de intervención en comparación con el grupo control
Majić et al. ¹⁹ , 2013	Investigar la eficacia de la AAT en síntomas de agitación/agresión y la depresión en ancianos institucionalizados con demencia	N: 54 Edad media 81,8	GC: 27 Tratamiento habitual GI: 27 Tratamiento habitual combinado con terapia asistida con animales	Duración: 10 sesiones durante 10 semanas Evaluación: evaluaciones al inicio, durante y 4 semanas después del experimento Se midieron: agitación, agresividad, depresión	MMSE CMAI DMAS	En el GC las 3 variables estudiadas, agitación, agresividad y depresión, aumentaron En el GI se mantienen constantes
Moretti et al. ¹⁸ , 2011	Evaluar los efectos de la terapia con animales en la función cognitiva, el humor y la percepción de calidad de vida en pacientes de edad avanzada afectados por demencia, depresión y psicosis	N: 21 Edad media 84,7	GC: 11 Ningún contacto con animales. Solo observarlos GI: 10 Terapia asistida con animales. Llevar perros y contacto con ellos	Duración: 6 semanas de tratamiento con una actividad a la semana Evaluación: evaluaciones al inicio y después de la intervención con los animales Se midieron: función cognitiva, calidad de vida, depresión	MMSE GDS Cuestionario autopercepción de la calidad de vida	Mejoría en ambos grupos tanto en GDS como en MMSE En el GI el GDS disminuyó al 50% y se produjo un aumento de MMSE con respecto a la evaluación inicial El MMSE aumentó en el GC, no apareciendo diferencias significativas

AAT: terapia asistida por animales; ABMI: Agitated Behavior Mapping Instrument; BPSD: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia; CA: control activity with plush dogs; CMAI: Cohen-Mansfield Agitation Inventory; CSDD: Cornell Scale for Depression in Dementia; DMAS: Dementia Mood Assessment scale; GC: grupo control; GDS: escala de depresión geriátrica; GI: grupo intervención; MDDAS: Multi-Dimensional Dementia Assessment Scale; MMSE: Minimental State Examination; NPI: Neuropsychiatric Inventory; OERS: Emotion Rating Scale for emotional status.

Tabla 2 Calidad Metodológica de los estudios incluidos

Artículo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Puntuación
Mosello et al. ²¹ (2011)	S	N	N	S	N	N	N	S	S	S	S	5 (justo)
Moretti et al. ¹⁸ (2011)	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	S	8 (bueno)
Majić et al. ¹⁹ (2013)	S	S	N	S	S	N	S	S	S	S	S	8 (bueno)

son escasos los ensayos clínicos que intentan comprobar los efectos que la terapia asistida con animales tiene en las personas con demencia.

El tamaño de la muestra de los artículos incluidos en esta revisión es limitada (oscila entre $N=10$ y $N=54$)^{19,21}. Al ser una muestra tan escasa, los resultados no pueden generalizarse al resto de población que presenta demencia.

Si tenemos en cuenta el animal con el que se han llevado a cabo las terapias, comprobamos que en los estudios incluidos en esta revisión^{18,19,21} el animal utilizado es un perro. En este aspecto, los datos obtenidos en esta investigación nos han ayudado a conocer los beneficios que proporcionan los perros a las personas con demencia, pero es complicado extrapolarlo a los gatos, y mucho menos conocer los beneficios de otros animales, ya que como hemos podido comprobar, en todos los estudios es de terapia canina.

En este aspecto nos podemos encontrar con multitud de raza de perros con distintas características. En los estudios incluidos en esta revisión se especifica únicamente en 2^{18,19} la raza del animal (boder collie, perros perdigueros, pincher, caniche, staffordshire, terrier y pastor alemán), no siendo en ninguno de los 2 casos el mismo tipo de perro. En el resto de los estudios²¹ no llegan a concretar la raza del animal. Por este motivo, es difícil especificar qué tipo de perro es más adecuado para intervenir con la población objeto de estudio.

Si nos centramos en el tipo de terapia que hace el grupo control observamos que la terapia llevada a cabo no es igual en ninguno de los estudios incluidos en esta revisión. En uno de los ensayos clínicos¹⁹, el grupo control realiza la terapia habitual que han realizado siempre, sin especificar cuál es, en otro de los estudios¹⁸ los participantes que forman parte del grupo control tienen contacto visual de los perros pero no llegan a interactuar con ellos. Por último, el trabajo realizado por Mosello et al.²¹ realiza con el grupo control una terapia basada en la utilización de perros de peluche. Con esta diversidad de tratamientos se dificulta la comparación de los resultados obtenidos en el grupo control. En algunas investigaciones^{19,21} se obtienen mejorías en algunas medidas de resultados, mientras que en otros estudios, en el que el grupo control realiza la terapia habitual o terapia con personas no se obtienen diferencias entre grupos¹⁸.

Además, no todos los participantes tenían el mismo tipo de demencia. En el estudio llevado a cabo por Moretti et al.¹⁸ es tipo Alzheimer, vascular y secundaria, al igual que en el trabajo realizado por Mosello et al.²¹. Por otro lado, en uno de los 3 estudios¹⁹ se conoce que los participantes del estudio padecen demencia pero no se especifica de qué tipo. Este aspecto hace que no podamos concretar para qué tipo de síndrome demencial es más adecuada la terapia asistida con animales, ya que cada tipo de demencia cursa con una serie de síntomas y signos específicos. No todos los síndromes demenciales tienen la misma sintomatología, por lo tanto, el abordaje podría ser diferente.

Cuando se habla de terapia asistida con animales no se hace referencia a la cantidad o frecuencia que deben de tener las sesiones, ya que son planificadas bajo objetivos terapéuticos²² y la duración irá en función de lo que se quiere conseguir. Si tenemos en cuenta este aspecto, en nuestra investigación obtenemos que en uno de los estudios incluidos en esta revisión¹⁸ la terapia se llevó a cabo en 6

sesiones; en el primero tuvieron lugar a lo largo de 6 semanas y en el segundo en una única semana; en otro estudio¹⁹, la duración es de 10 semanas, con una sesión semanal. En el trabajo realizado por Mosello et al.²¹, la duración fue de 8 semanas, con 3 sesiones semanales. Todas las investigaciones experimentan beneficios en los grupos que realizaron terapia asistida con animales. Por lo que podemos comprobar, a través de los datos obtenidos, que en todos los estudios se producen mejorías en medidas de resultados o mantenimiento de las mismas, independientemente de la frecuencia o duración de las sesiones con animales.

La institucionalización de las personas que presentan demencia es algo importante a tener en cuenta, debido a la sobrecarga del cuidador por la sintomatología de la enfermedad. En todos los artículos incluidos en esta revisión^{18,19,21}, la terapia asistida con animales se lleva a cabo en residencias de ancianos. Por lo que conocemos que en este ámbito esta terapia no farmacológica puede mejorar la sintomatología de estos pacientes y sería conveniente estudiarla en otras áreas para poder extrapolar los resultados a otro tipo de nivel asistencial que no sea el residencial.

En lo referido a los instrumentos psicométricos utilizados en los ensayos clínicos encontramos también algunas limitaciones. En 2 artículos^{18,19} se utiliza el Minimental State Examination; Moretti et al.¹⁸ utilizan además la GDS y un cuestionario de autopercepción para valorar la calidad de vida. La CMAI es utilizada por Majić et al.¹⁹ y Mosello et al.²¹ para valorar el nivel de agitación de los pacientes, utilizando estos últimos además la escala Multi-Dimensional Dementia Assessment Scale para valorar la demencia. El trabajo realizado por Mosello et al.²¹ es el que más pruebas de valoración utiliza, no coincidiendo con ninguno de los trabajos anteriores excepto en una y encontrándose entre ellas Cornell Scale for Depression in Dementia, Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia, NPI, Emotion Rating Scale for emotional status o Agitated Behavior Mapping Instrument. La gran heterogeneidad de los instrumentos de evaluación, así como la variedad de resultados obtenidos, reduce bastante el conocimiento sobre los beneficios que puede producir la terapia asistida con animales en las medidas evaluadas y el nivel de significación de los mismos.

Otra limitación que nos encontramos en lo referido a los instrumentos psicométricos es que a la hora de valorar la medida de resultado los autores utilizan diferentes instrumentos. De esta manera, a la hora de valorar el estado de ánimo se utiliza la GDS en uno de ellos¹⁸ y la Dementia Mood Assessment Scale¹⁹. El hecho de utilizar diferentes instrumentos psicométricos para la valoración de una misma medida de resultado puede complicar el análisis global de los datos y, por lo tanto, introducir sesgos, evitando la obtención de un resultado sólido sobre la temática objeto de estudio.

En todos los estudios incluidos en esta revisión, el grupo experimental ha presentado alguna mejora o mantenimiento en las medidas de resultado tomadas (comportamiento, calidad de vida, estado anímico, el estado cognitivo, las actividades de la vida diaria y el estrés mental) con respecto al grupo control que no realizaba terapia asistida con animales. Sin embargo, solo en uno de los estudios¹⁸ se ha podido comprobar cómo el grupo control ha mejorado en todas las medidas de resultados tomadas. En este ensayo, comprobamos como el grupo control tuvo contacto con los animales,

al contrario que en el resto de los estudios, que llevaron a cabo o la terapia habitual o terapia con personas. Podemos deducir de este resultado que el tener un contacto con un animal únicamente visual, sin necesidad de acariciarlo o jugar con él, produce beneficios en las personas que lo llevan a cabo.

Las conclusiones podrían ser más significativas realizando estudios cuyo criterio de inclusión sea la limitación de un tipo específico de demencia y homogeneizando la metodología para poder comparar los resultados y así poder ofrecer resultados más firmes en la mejora de la calidad de vida de estos mayores.

Así pues, las limitaciones del estudio recaen en la falta de estudios sobre la temática analizada, así como la heterogeneidad de los existentes en cuanto a patología de los participantes y metodología utilizada. Se trata de una terapia joven y en auge en la cual la investigación a fecha de hoy es escasa.

Conclusión

En los últimos años, existen pocos estudios que aborden el tema de la terapia asistida con animales utilizada en pacientes con demencia.

Los resultados de esta revisión muestran que la terapia canina produce beneficios en el comportamiento, el estado de ánimo, la calidad de vida, las actividades de la vida diaria y el estrés mental de personas que presentan demencia, en comparación con otro tipo de terapia.

Son necesarios estudios futuros que cumplan criterios mínimos de calidad metodológica con procedimientos de actuación homogéneos en el diseño, así como en la duración, la frecuencia y los instrumentos de medidas utilizados.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Prieto C, Eimil M, López C, Llanero M. Impacto social de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. San Sebastián de los Reyes: Fundación Española de Enfermedades Neurológicas (FEEN); 2011. p. 1–47.
- Organización Mundial de la Salud. Demencia, una prioridad de salud pública. Washington DC: Organización Mundial de la Salud; 2013.
- Olazarán J, Reisberg B, Clare L, Cruz I, Peña-Casanova J, del Ser T, et al. Eficacia de las terapias no farmacológicas en la enfermedad de Alzheimer: una revisión sistemática. *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2010;32:161–78.
- Gobierno de Canarias, Servicio Canario de Salud. Tratamiento farmacológico específico de las demencias. En: Gobierno de Canarias; Servicio Canario de Salud. Manual de actuación en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Las Palmas de Gran Canaria: Gobierno de Canarias, Consejería de Sanidad. Dirección General de Programas Asistenciales; 2011. p. 125–34.
- Olazarán J, Bermejo F. Tratamiento actual de las demencias. *Jano: Medicina y Humanidades*. 2009;1742:29–32.
- Muñiz R, Olazarán Rodríguez J. Mapa de terapias no farmacológicas para demencias tipo Alzheimer. Guía de iniciación técnica para profesionales. Salamanca: Fundación María Wolff; 2009. p. 1–21.
- Abellán RM. La terapia asistida por animales: una nueva perspectiva y línea de investigación en la atención a la diversidad. *Indivisa: Boletín de Estudios e Investigación*. 2008;9: 117–46.
- AFA Parla. Blog tú preguntas, yo respondo [Internet]. Parla: AFA Parla; 15 de Mayo de 2014 [consultado 4 Mar 2015]. Disponible en: <http://tupreguntas.blogspot.com.es>
- Mariscal T. Terapia asistida con animales y síndrome de Down. Fundación Bocalán. Todo Perros [e revista on-line]. 2008 [consultado 2 Mar 2015]. Disponible en: <http://www.labradoresdebocalan.com/down.pdf>
- Tellier M, Vila M. Protocolos de actividad para usuarios con trastornos de «espectro autista» en un programa de terapia asistida por animales (TEAAC). Barcelona: Fundación Affinty; 2003.
- Jofré L. Visita terapéutica de mascotas en hospitales. *Rev Chilena Infectol*. 2005;22:257–63.
- De Campos MV, Mavel V. Terapia asistida con animales (TACA). Lima: Asociación de Docentes Pensionistas de la Universidad Nacional Mayor San Marcos ASDOPEN-UNMSM; 2014. p. 18.
- Cordones V. Aplicación de la terapia asistida con animales de compañía para la mejora de la calidad de vida en las personas mayores institucionalizadas de la Residencia de Mayores de Nuestra Señora de la Piedad de Quintanar de la Orden (Toledo) [trabajo fin de grado]. Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha; 2011.
- Llopis MA. Terapia/actividad Asistida por animales y la 3.ª edad. Valencia: Asociación de terapias y Actividades asistidas con animales de la SAFOR; 2009. p. 1–5.
- Tellier M, Vila M. Protocolos de actividad para gente mayor en un programa de terapia asistida por animales (TEAAC). Barcelona: Fundación Affinty; 2003.
- PEDro [base de datos de Internet]. Australia: Centre for Evidence-Based Physiotherapy [consultado 27 Mar 2015]. Disponible en: <http://www.pedro.org.au/spanish/>
- Izquierdo E, Fernández E, Sitjas M, Elías M, Chesa D. Depresión y riesgo de demencia. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*. 2003;87:156–60.
- Moretti F, de Ronchi D, Bernabei V, Marchetti L, Ferrari B, Forlani C, et al. Pet therapy in elderly patients with mental illness. *Psychogeriatrics*. 2011;11:125–9.
- Majić T, Gutzmann H, Heinz A, Lang UE, Rapp MA. Animal-assisted therapy and agitation and depression in nursing home residents with dementia: A matched case-control trial. *Am J Geriatr Psychiatry*. 2013;21:1052–9.
- Martínez A. Trastornos de conducta en personas con demencia. 3 de mayo de 2013 [consultado 4 Mar 2015]. Disponible en: <http://www.slideshare.net/amarlu80/trastornos-de-conducta-en-las-personas-con-demencia>

21. Mosello E, Ridolfi A, Mello AM, Lorenzini G, Mugnai F, Piccini C, et al. Animal-assisted activity and emotional status of patients with Alzheimer's disease in day care. *Int Psychogeriatr*. 2011;23:899–905.
22. Petpartners.org. Animal assisted therapy [sede web]. USA: Petpartners.org; 2012-[actualizada 5 Dic 2013; consultado 2 Mar 2015]. Disponible en: <http://www.petpartners.org>